

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DE BULIMIA DE EDIMBURGO (BITE)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Específica de Atracones, Purgas y Gravedad de Bulimia Nerviosa

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test de Bulimia de Edimburgo (BITE).
Nombre Original (Inglés)	<i>Bulimic Investigatory Test, Edinburgh (BITE)</i>
Autores Originales	M. Henderson y C. P. Freeman (1987), University of Edinburgh.
Adaptaciones Españolas	Rivas, Zerpa, Castro y Puigcerver (2004, validación de referencia); Bobes et al. (2004, CIBER-SAM).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Cribado y graduación de gravedad en bulimia y atracones.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 33 reactivos estructurado en dos escalas: Subescala de Síntomas (30 ítems) y Subescala de Gravedad (3 ítems).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (>= 14 años). Consultas de salud mental, nutrición y atención primaria.
Tiempo de Administración	8 a 12 minutos.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico y de investigación médica no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO DISOCIADO SÍNTOMAS-GRAVEDAD

El test BITE fue formulado por Henderson y Freeman (1987) para dar respuesta a una carencia psicométrica crítica de los inventarios generales de alimentación (como el EAT): la incapacidad para aislar y diferenciar con precisión la **presencia cognitiva de síntomas bulímicos** de la **gravedad objetiva y frecuencia de las conductas purgativas**.

El diseño innovador del BITE radica en su arquitectura dual: mientras la **Subescala de Síntomas** identifica la pérdida subjetiva de control, el hábito de comer a escondidas y la culpa postprandial, la **Subescala de Gravedad** mide exclusivamente la periodicidad de los actos compensatorios nocivos (vómitos provocados, uso de laxantes, ayunos estrictos y fármacos anorexígenos). Esta disociación resulta crucial tanto para el diagnóstico diferencial de la Bulimia Nerviosa y el Trastorno por Atracón como para monitorizar la respuesta objetiva al tratamiento.

3. ESTRUCTURA Y SUBESCALAS DEL BITE (HENDERSON & FREEMAN, 1987)

Subescala BITE	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Significación Clínica
1. Subescala de Síntomas	1 al 30	0 a 30	Presencia de atracones, ingesta descontrolada, comer a escondidas, culpa y distorsión cognitiva.
2. Subescala de Gravedad	31 al 33	0 a 39	Frecuencia temporal de conductas purgativas: vómitos inducidos, abuso de laxantes y ayunos compensatorios.
PUNTUACIÓN TOTAL BITE	1 al 33	0 a 69	Índice acumulativo de presencia sintomática y severidad conductual bulímica.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Elevada consistencia interna: alfa de Cronbach de 0.89 a 0.92 para la Subescala de Síntomas y 0.83 a 0.87 para la Subescala de Gravedad en la validación española de Rivas et al. (2004).
Sensibilidad y Especificidad	Para el punto de corte <i>ge20</i> en la Subescala de Síntomas: sensibilidad del 93% y especificidad del 90% para Bulimia Nerviosa frente a entrevistas estructuradas DSM.
Validez Concurrente	Correlación muy alta con la escala de Bulimia del EDI-2 ($r = 0.84$) y con la subescala bulímica del EAT-40 ($r = 0.76$).
Fiabilidad Test-Retest	Coefficiente de correlación intraclass $r = 0.85$ a las tres semanas en muestras ambulatorias estables.
Capacidad Discriminante	Distingue eficazmente entre Bulimia Nerviosa franca, Anorexia Restrictiva Pura y Trastornos de Ansiedad comórbidos sin atracones.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN DE LAS SUBESCALAS

El protocolo se corrige computando de forma independiente cada una de las dos subescalas:

- **Subescala de Síntomas (Ítems 1 al 30):** Respuestas dicotómicas (**Sí / No**). Las respuestas que indican descontrol bulímico puntúan **1 punto**; las respuestas adaptativas puntúan **0 puntos**.

Subescala de Síntomas: 0 a 30 puntos | Corte Clínico Positivo *ge20* puntos

- **Subescala de Gravedad (Ítems 31 al 33):** Opciones politómicas de frecuencia graduada (nunca, semanal, diario o varias veces al día). Rango: **0 a 39 puntos**. Puntuación *ge5* denota gravedad clínica relevante; *ge10* indica gravedad extrema.

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (RIVAS ET AL., 2004; HENDERSON, 1987)

Nivel	Síntomas	Estado Bulímico	Conducta Asistencial Recomendada
Normal	0 a 9	Patrón alimentario normativo	Ausencia de síntomas bulímicos. No se requiere intervención.
Medio	10 a 19	Patrón alimentario inusual / Subclínico	Conductas de atracón esporádicas o dieta caótica. Psicoeducación nutricional y seguimiento.
Clínico	20 a 30	Corte Positivo (Patrón Bulímico Grave)	Cumple criterios para Bulimia Nerviosa o Trastorno por Atracón. Evaluación diagnóstica formal.
Gravedad	Grav. <i>ge5</i>	Conductas Purgativas Activas	Peligro somático por vómitos/laxantes frecuentes. Monitorización médica electrolítica urgente.

COMBINACIÓN DE CRITERIOS DIAGNÓSTICOS EN EL BITE: Un paciente con **Síntomas *ge20*** y **Gravedad *ge5*** reúne todos los criterios diagnósticos formales de Bulimia Nerviosa activa del DSM-5. Si los Síntomas son *ge20* pero la Gravedad es < 5 (sin purgas regulares), el cuadro suele corresponder a un Trastorno por Atracón puro.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y ENFOQUE TERAPÉUTICO

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA SECUENCIAL SEGÚN EL BITE:

- **Paso 1 (Gravedad *ge5*):** Evaluar y corregir de inmediato la inestabilidad biológica. Solicitar ionograma plasmático urgente para descartar hipopotasemia silente y pautar suplementación de potasio si procede.
- **Paso 2 (Abordaje de Síntomas):** Si la puntuación de síntomas es *ge20*, iniciar Terapia Cognitivo-Conductual transdiagnóstica para TCA (Fairburn). Reinstaurar el patrón regular de comidas cada 3–4 horas para quebrar el bucle fisiológico ayuno-atracón-purga.
- **Paso 3 (Farmacoterapia Coadyuvante):** En pacientes con bulimia y BITE severo, la fluoxetina a dosis de 60 mg/día ha demostrado reducir la frecuencia de impulsos bulímicos y estabilizar el estado de ánimo disfórico.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: BULIMIA NERVIOSA EN ATENCIÓN AMBULATORIA

Paciente: Mujer de 24 años, graduada universitaria, que consulta por dolor de garganta crónico, reflujo gastroesofágico severo y sensación deses-perada de descontrol alimentario nocturno que oculta a su pareja.

Resultados BITE:

- **Subescala de Síntomas: 26/30 (Corte Positivo — Patrón Bulímico Severo).** Refiere atracones masivos diarios en soledad, sensación de trance durante la ingesta y pánico intenso a ganar peso.
- **Subescala de Gravedad: 11/39 (Gravedad Clínica Severa).** Indica provocarse el vómito 2 a 3 veces al día y tomar comprimidos laxantes los fines de semana tras ingestas abundantes.

Conducta Asistencial: Se diagnostica Bulimia Nerviosa de Gravedad Severa (DSM-5). La analítica revela K⁺ de 3.1 mEq/L, iniciándose reposición oral de gluconato de potasio. Se pauta fluoxetina 60 mg/día y psicoterapia cognitivo-conductual con autorregistro de ingestas y reestructuración de la dicotomía de alimentos prohibidos versus permitidos. A las 10 semanas de tratamiento, la Subescala de Síntomas bajó a 8/30 y la Subescala de Gravedad a 1/39, con cese completo de los vómitos.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y COMPLICACIONES SOMÁTICAS

ALERTA: ROTURA ESOFÁGICA / GÁSTRICA

Los vómitos forzados violentos y repetidos conllevan riesgo letal de desgarros de la mucosa de la unión esofagogástrica (Síndrome de Mallory-Weiss) y perforación esofágica (Síndrome de Boerhaave).

DESEQUILIBRIO HIDROELECTROLÍTICO

Puntuaciones de gravedad *ge10* exigen monitorización analítica de iones en suero (sodio, potasio, cloro) y control periódico de la función renal por riesgo de insuficiencia prerrenal aguda.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Henderson, M., & Freeman, C. P. (1987). A self-rating scale for bulimia: the «BITE». *The British Journal of Psychiatry*, 150(1), 18–24.
2. Rivas, T., Zepa, C., Castro, Y., & Puigcerver, P. (2004). Spanish version of the Bulimic Investigatory Test Edinburgh (BITE): psychometric properties. *European Eating Disorders Review*, 12(6), 381–388.
3. Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Medica.
4. Fairburn, C. G., & Beglin, S. J. (1990). Studies of the epidemiology of bulimia nervosa. *The American Journal of Psychiatry*, 147(4), 401–408.